

PERSBERICHT

23 januari 2026

Verslag aan het federale parlement: Voorschrijven en afleveren van antibiotica: opvolging 2025 van de aanbevelingen



In een audit van 2022 onderzocht het Rekenhof het beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica. België is immers een van de Europese landen die de meeste antibiotica gebruiken. Overmatig gebruik ervan vergroot echter de bacteriële resistentie. Elk jaar veroorzaakt dit in België ongeneeslijke infecties, met nawerkingen en honderden doden tot gevolg, alsook overheidsuitgaven die worden geschat op 281 miljoen euro. Het beleid dat in 2022 werd gevoerd was ontoelreffend. Het Rekenhof beval de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG aan maatregelen te nemen om de kwaliteit van de voorschriften te verbeteren en de hoeveelheid onnodig verstrekte antibiotica te verminderen. In zijn opvolging van 2025 stelt het Rekenhof vast dat er aanzienlijke vooruitgang werd geboekt en dat het aantal terugbetaalde antibiotica met 8 % is gedaald. Het aantal antibiotica dat wordt voorgeschreven buiten de terugbetalingsvoorwaarden om, en dus buiten de controle van het RIZIV, neemt echter toe.

Hoe meer antibiotica worden gebruikt, hoe resistenter bacteriën worden en hoe minder doeltreffend de antibiotica werken. Zonder doeltreffende antibiotica zijn talrijke, soms dodelijke infecties echter niet meer te behandelen. Die ongeneeslijke infecties leiden tot extra geneeskundige verzorging en dus tot uitgaven voor de sociale zekerheid, in het bijzonder ziekenhuiskosten.

Indien de economische verliezen (arbeidsongeschiktheid en productiviteitsverlies) daarbij zouden worden opgeteld, zouden de financiële gevolgen voor België oplopen tot 281 miljoen euro per jaar. Er bestaan echter doeltreffende oplossingen om resistentie te verminderen, bv. antibiotica voorschrijven volgens de goede klinische praktijken en alleen de hoeveelheid verstrekken die nodig is voor de behandeling.

In zijn initiële audit van 2022 stelde het Rekenhof vast dat België, ondanks een vernieuwend beleid in 1999, nog steeds een van de Europese landen was die de meeste antibiotica gebruikten. Er was een gebrek aan efficiënte omkadering voor het voorschrijven en afleveren van antibiotica, evenals aan nauwkeurige gegevens over de verstrekte antibiotica en de doeltreffendheid van de genomen maatregelen. Het percentage afleveringen van sommige antibiotica waarvan het gebruik volgens de goede klinische praktijken beperkt had moeten

zijn, bleef bovendien te hoog. Die antibiotica kunnen echter invaliderende en soms onomkeerbare bijwerkingen veroorzaken.

In 2022 concludeerde het Rekenhof dat de omkadering voor het voorschrijven en afleveren van antibiotica niet doeltreffend was. Bijgevolg formuleerde het aanbevelingen opdat de FOD Volksgezondheid, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doeltreffendere maatregelen zouden treffen.

In het kader van zijn opvolging in 2025 onderzocht het Rekenhof of de FOD, het RIZIV en het FAGG de twintig aanbevelingen uit zijn initiële audit van 2022 hebben uitgevoerd. Drie jaar na die initiële audit komt het tot de conclusie dat zes aanbevelingen zijn uitgevoerd, tien gedeeltelijk zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn, twee niet zijn uitgevoerd en de uitvoering van twee die niet kan worden beoordeeld.

Het Rekenhof merkt op dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt wat betreft de controle op de voorschriften, meer bepaald met de publicatie eind 2023 van indicatoren van goede klinische praktijken. Aan de hand van die indicatoren kan het RIZIV de kwaliteit van huisartsenvoorschriften beoordelen. Vergeleken met 2019 daalden de terugbetaalde antibiotica tussen juni 2024 en mei 2025 met 8 %, wat erop zou kunnen wijzen dat de getroffen maatregelen doeltreffend zijn. Een andere effectieve maatregel om de verstrekking van onnodige antibiotica te beperken, is de verplichting om de exacte hoeveelheid af te leveren, die in april 2026 moet worden doorgevoerd.

Alle niet-terugbetaalde geneesmiddelen ontsnappen echter aan de controle van het RIZIV. Het aandeel van die niet-terugbetaalde antibiotica ten opzichte van de terugbetaalde antibiotica is echter toegenomen tussen 2019 (11 %) en 2023 (12 %). In 2023 werden sommige antibiotica met mogelijk ernstige bijwerkingen zelfs meestal buiten de terugbetalingsvoorwaarden om voorgeschreven. Aangezien deze voorwaarden bedoeld zijn om de naleving van de goede klinische praktijken op te leggen, is het voorschrijven van die antibiotica buiten de terugbetalingsvoorwaarden mogelijk niet in overeenstemming met die goede praktijken.

Voorschrijven buiten de terugbetalingsvoorwaarden om heeft negatieve gevolgen voor de patiënt. Die betaalt immers de volledige prijs van het antibioticum en loopt het risico te worden blootgesteld aan de bijwerkingen van een antibioticum, dat misschien niet voorgeschreven had moeten worden. De algemene bevolking betaalt ook de prijs voor die gebrekkige naleving van goede praktijken, door de toename van antibioticaresistente infecties en de daaruit voortvloeiende kosten voor de sociale zekerheid.

Informatie voor de pers

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige

en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.

Het verslag 'Beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica: opvolging 2025 van de aanbevelingen' werd aan het federale parlement bezorgd. Het verslag en dit persbericht zijn terug te vinden op rekenhof.be.